

Manutenção ou suspensão da alimentação e hidratação artificial em fim de vida: reflexão bioética baseada num caso clínico

Maintenance or withdrawal of artificial nutrition and hydration at the end of life: bioethical reflection based on a case report

Petra Chaves¹, Maria Ana Sobral², Gabriela Machado³

¹ ACES Sintra, Equipa Comunitária de Suporte em Cuidados Paliativos Sintra, Portugal

 <https://orcid.org/0000-0002-6532-3236>

² ACES Sintra, Equipa Comunitária de Suporte em Cuidados Paliativos Sintra, Portugal

 <https://orcid.org/0000-0002-7402-9186>

³ ACES Almada-Seixal, USF São João do Pragal, Almada, Portugal

 <https://orcid.org/0000-0002-5899-746X>

Palavras-chave

Cuidados paliativos; Cuidados terminais; Ética; Alimentação artificial; Hidratação artificial.

Resumo

Introdução: A manutenção ou suspensão da alimentação e hidratação artificial no doente em fim de vida é um dilema ético frequente na atualidade. Em contexto domiciliário, esta é uma questão que profissionais de saúde, doentes e famílias enfrentam com muita proximidade, obrigando a uma reflexão contínua sobre a conduta no melhor interesse da pessoa doente.

Objetivo: Reflexão bioética sobre manutenção ou suspensão da alimentação e hidratação artificial no doente em fim de vida, em contexto domiciliário.

Materiais e métodos: A partir da análise de um caso clínico, fez-se uma reflexão bioética sobre o problema da manutenção ou suspensão da alimentação e hidratação artificial, em contexto domiciliário, tendo em conta os princípios éticos da beneficência, não maleficência e autonomia.

Resultados: Foram considerados os princípios da beneficência e não maleficência, tendo em conta os riscos e os benefícios da alimentação e hidratação artificial e o ponto na trajetória da doença. Foi também considerado o princípio da autonomia, uma vez que a doente tinha expressado vontade em permanecer em casa, aceitando medidas de conforto e qualidade de vida.

Conclusão: Neste caso, após discussão em equipa e com a família, foi tomada a decisão de suspender a alimentação e hidratação artificial. A reflexão bioética revela-se essencial na tomada de decisão perante problemas éticos complexos, sendo uma das competências nucleares das equipas especializadas em cuidados paliativos.

Keywords

Palliative care; Terminal care; Ethics; Artificial nutrition; Artificial hydration.

Abstract

Introduction: The maintenance or withdrawal of artificial nutrition and hydration regarding patients at the end of life is nowadays a frequent ethical dilemma. In a home-based context, this is an issue that health care providers, patients and families face together, and requires continuous reflection on conduct in the best interest of the ill patient.

Aim: To promote a bioethical reflection on maintenance or withdrawal of artificial hydration and nutrition of patients at the end of life in a home-based context.

Materials and methods: Bioethical clinical case analysis respecting the challenging problem of maintenance or withdrawal of artificial nutrition and hydration in a home-based care environment, taking into account the ethical principles of beneficence, non-maleficence and autonomy.

Results: Regarding the risks and benefits of artificial nutrition and hydration and the point in the trajectory of the disease, the ethical principles of beneficence and non-maleficence were considered. The principle of autonomy was also taken into account, as the patient expressed the will to stay at home and had accepted comfort and quality of life measures.

Conclusion: After discussion with the team and family, it was decided to withdraw artificial nutrition and hydration. Bioethical reflection is essential in decision-making concerning complex ethical problems, being one of the core competencies of palliative care specialized teams.

Introdução

Os cuidados paliativos promovem a qualidade de vida de pessoas e familiares que enfrentam doenças que ameaçam a continuidade da vida, através da prevenção e alívio do sofrimento. Requerem a identificação precoce, avaliação e tratamento de problemas do domínio físico, psicossocial e espiritual.¹ Esta abordagem multidimensional está associada a desafios éticos, nomeadamente a instituição, manutenção ou suspensão de intervenções invasivas.² A alimentação e hidratação artificial (AHA), descritas como tratamento médico que viabiliza a nutrição por via endovenosa ou entérica nos doentes com risco de perda da via oral, é um dos desafios no âmbito dos cuidados paliativos. A frequência da sua implementação e manutenção, em particular na pessoa em fim de vida, de acordo com a evidência mais recente, não é conclusiva podendo variar entre 3 e 50% no último mês de vida.³ Esta variabilidade poderá justificar-se com estudos em diferentes contextos, nomeadamente culturais.³

A gastrostomia endoscópica percutânea (PEG) é um dos procedimentos propostos para a AHA na impossibilidade de utilização da via oral. É ponderada com base em dois pressupostos teóricos: otimizar o controlo de sintomas e aumento da sobrevida.^{4,5,6} No entanto, a evidência destes benefícios na pessoa com prognóstico limitado e indicação exclusiva para cuidados paliativos é escassa e contraditória, não existindo dados consistentes sobre melhoria do estado nutricional, impacto funcional e qualidade de vida.⁷ À data, não foram publicadas recomendações formais sobre a manutenção ou suspensão das mesmas neste contexto.⁸

A sua manutenção ou suspensão, tendo em conta o significado total da alimentação além do seu papel fisiológico, a ausência de concordância entre benefícios e riscos, a variabilidade do trajeto de doença e fim de vida, levantam questões éticas nomeadamente à luz dos princípios da autonomia, beneficência e não maleficência. Este artigo pretende, a propósito de um caso clínico, discutir e refletir sobre a complexidade de decisões relacionadas com AHA em fim de vida do ponto de vista ético.

Caso clínico

Mulher de 65 anos de idade, natural de Angola, divorciada, que residia em habitação própria com dois dos cinco filhos. Em maio de 2019 foi-lhe diagnosticado carcinoma pavimento-celular do

palato mole (T1N3bMx), tendo cumprido ciclos de radioterapia e quimioterapia, suspensos posteriormente por toxicidade sistémica. Pela progressão locorregional da doença e aparecimento de ferida maligna na região cervical, em outubro de 2019, houve necessidade de realização de traqueostomia transtumoral e PEG.

Em maio de 2021 foi referenciada pela equipa intra-hospitalar de suporte em cuidados paliativos para a equipa comunitária de suporte em cuidados paliativos (ECSCP) da área de residência. Os objetivos traçados entre as equipas, doente e família eram garantir o controlo de sintomas e a realização do penso da ferida maligna no domicílio, evitando idas desnecessárias ao hospital. Não foi abordado o prognóstico (esperança de vida de meses) e desejo do local de morte por recusa da doente e família, que mantinham esperança na cura apesar de conscientes da gravidade clínica. À data da primeira consulta de acompanhamento da ECSCP, a doente encontrava-se orientada no tempo, espaço e pessoa, parcialmente dependente nas atividades da vida diária (Palliative Performance Scale 50%).

Contava com uma rede de cuidadores informais bem estruturada e de fortes laços afetivos: uma filha e um filho como principais cuidadores, que apoiavam na confeção e administração das refeições, auxiliavam na realização dos pensos e nos cuidados de higiene. Os outros dois filhos e o ex-marido prestavam cuidados mais pontuais. Sem cuidador formal. Apresentava ferida maligna complexa com exsudado mucopurulento e episódios de hemorragia, tendo necessidade de realização de pensos em dias alternados. Apesar da dificuldade na comunicação oral, era evidente a importância da manutenção das decisões sobre questões de saúde e gestão da vida pessoal, nas quais a doente participava ativamente em conjunto com a família. Apresentava um adequado controlo sintomático, com a dor e o odor na realização dos pensos e a quantidade abundante de secreção na via aérea superior como principais desafios. As questões relacionadas com a realização do penso da ferida maligna e com a alimentação eram as principais preocupações da doente e dos cuidadores. Com a evolução da doença e a necessidade crescente de antecipar questões relacionadas com o final de vida, risco de hemorragia da ferida maligna, risco de sufocação e dispneia, foi realizada conferência familiar com a presença dos filhos e da doente. Foram abordadas questões como morte em casa e controlo sintomático no domicílio, tendo sido possível à doente expressar o seu desejo de

permanência em casa e a aceitação de medidas para promover o máximo conforto e qualidade de vida.

Perante o quadro clínico de doença oncológica progressiva e irreversível, a equipa deparou-se com os dilemas éticos da suspensão da AHA.

Discussão

No caso clínico apresentado o problema ético é a manutenção ou suspensão da AHA na pessoa em fim de vida, em contexto domiciliário, apoiada por uma equipa comunitária de suporte em cuidados paliativos.

Prestar os melhores cuidados em final de vida faz parte do cuidado integral da pessoa preconizado pelos cuidados paliativos. A abordagem técnica deve ser pensada à luz de uma orientação ética e humanista, considerando os potenciais riscos e benefícios de intervenções invasivas.⁹ Este equilíbrio é particularmente complexo na pessoa em últimos dias ou horas de vida quer pela dificuldade na identificação dos sinais de morte iminente, quer pela ausência de orientações específicas em relação às melhores práticas nesta fase de doença.¹⁰ A decisão sobre manutenção ou suspensão da AHA, na perspetiva de prestar os melhores cuidados centrados no alívio do sofrimento e melhoria da qualidade de vida, é complexa. Envolve não só dados clínicos mas também a incerteza sobre o benefício e risco de algumas intervenções, e o significado da alimentação para a pessoa e família. Acresce a isto as perspetivas pessoais, influenciadas pelo contexto cultural e espiritual de todos os intervenientes.¹¹ A AHA levanta questões respeitantes aos princípios éticos mais importantes, em particular o princípio da autonomia, beneficência e não maleficência. Estes princípios, a par do princípio da justiça, são indissociáveis e reconhecidos como direitos fundamentais consagrados na Convenção Europeia dos Direitos do Homem.¹² Na análise do caso clínico descrito optámos por fazer a reflexão de acordo com esses princípios face ao dilema ético entre manutenção ou suspensão de AHA na pessoa em fim de vida.

Princípio da autonomia: Baseia-se no reconhecimento da legitimidade de a pessoa tomar decisões livres e informadas e assumir as suas escolhas pessoais. Para o seu cumprimento é fundamental que os doentes tenham acesso a informações apropriadas tanto na forma como no conteúdo e capacidade para compreender objetivos, riscos e benefícios das intervenções, alternativas ao tratamento e

consentimento informado. Avaliar a capacidade da pessoa para participar plenamente nas decisões e indagar os desejos previamente manifestados é uma parte indispensável do processo de decisão. Assume particular relevância nas pessoas cujas capacidades funcionais se encontram diminuídas, fruto da progressão natural da doença.¹³ A família deve ser auscultada mas as suas vontades não se devem sobrepor às decisões do próprio, podendo ser assumido um compromisso no melhor interesse do doente. Neste caso a doente manifestou o seu desejo de manutenção de conforto e de ser cuidada em casa, no entanto, não foi discutida a questão da suspensão de AHA quando do agravamento clínico.

Não tendo sido abordada a elaboração de diretizes antecipadas de vontade nem existindo um representante legal formal e estando a pessoa incapaz de expressar a sua vontade no momento, consideramos que os princípios da beneficência e não maleficência superaram o princípio da autonomia – quando um princípio entra em conflito com outro é obrigação das equipas analisarem o peso de ambos no contexto e decidir no melhor interesse da pessoa.^{12,14}

Princípio da beneficência e não maleficência: O princípio da beneficência é o princípio que descreve a obrigação de o profissional decidir em prol do benefício da pessoa doente, centrado na promoção do bem-estar e cuidados regidos pela melhor evidência disponível. O princípio da não maleficência, por seu lado, refere-se a evitar atos que potencialmente possam provocar dano.^{12,13} O equilíbrio entre ambos é uma das chaves da ética na Medicina: prover aos doentes tratamentos proporcionados e adaptados à sua situação. Implicam a reflexão entre tratamento adequado e tratamento desproporcional e passível de ser descontinuado. Um tratamento adequado e proporcional poderá ser entendido como aquele que tem em conta o benefício em termos de resultados do tratamento da doença ou dos sintomas mas também a qualidade de vida do doente. Torna-se desproporcional quando acarreta riscos superiores aos benefícios.^{12,13} Na situação de pessoa em fim de vida esta reflexão e processo de decisão é particularmente complexa, nomeadamente no que diz respeito à manutenção ou suspensão de tratamentos invasivos.

Neste caso a doente, ao entrar nos últimos dias de vida, apresentava um adequado controlo de sintomas. Tal foi conseguido através de um acompanhamento de proximidade da equipa e da utilização de diferentes estratégias farmacológicas e não farmacológicas

como terapêutica através da via subcutânea e espaço para a família se expressar. Nas últimas duas semanas de vida a doente apresentava uma PPS de 20%, sem sinais de sofrimento. No entanto, foram relatados pela família dois episódios de regurgitação alimentar. Face a isso, a equipa considerou necessária a suspensão da AHA, já previamente discutida. A família apesar de consciente do prognóstico, apresentou dificuldade na aceitação da indicação por medo de acelerar o processo de morte.

A nutrição em cuidados de fim de vida é pensada com o objetivo de responder às necessidades da pessoa e promover conforto e qualidade de vida.¹⁵ Tendo por base os princípios da beneficência e não maleficência, a sua suspensão permitiu otimizar os cuidados e garantir o pedido expresso da doente em permanecer no domicílio com o mínimo desconforto associado.

Conclusões

Neste artigo procuramos refletir sobre a manutenção ou suspensão da AHA na pessoa em fim de vida, enquadrada à luz dos princípios éticos que devem orientar o processo de decisão clínica.

No contexto de progressão de doença e entrada em fim de vida, acompanhar o doente e a família no processo de compreensão do diagnóstico, prognóstico e na tomada de decisão, é fundamental. Este acompanhamento permite que as equipas de cuidados paliativos auxiliem no momento de decidir sobre a adequação de medidas de acordo com os objetivos da pessoa doente, tentando garantir o conforto e evitar medidas que provoquem agravamento do sofrimento físico e existencial. A AHA é um procedimento médico que tem indicações, objetivos e deve ser suportada por evidência científica robusta. É também um ato revestido de significado de acordo com variáveis culturais, religiosas e individuais e a sua manutenção ou suspensão é um dos dilemas mais frequentes no âmbito dos cuidados paliativos. A sua proporcionalidade e adequação tem de ser cuidadosamente ponderada.

No caso apresentado, após discussão em equipa e ponderação dos princípios da autonomia, beneficência e não maleficência, foi decidido, no melhor interesse da doente, pela suspensão da AHA. 

Conflitos de interesses

As autoras declaram não possuir quaisquer conflitos de interesse.

Financiamento

Este trabalho não foi objeto de qualquer tipo de financiamento.

Referências bibliográficas

1. Radbruch L, Payne S. White paper on standards and norms for hospice and palliative care in Europe: part 1 [Internet]. Eur J Palliat Care. 2009 [citado 2022 jul 3];16(6):278-289. Disponível em: <https://eapcresearchcongress2020.eu/wp-content/uploads/2020/11/White-Paper-on-standards-and-norms-for-hospice-and-palliative-care-in-Europe.pdf>.
2. Schofield G, Dittborn M, Huxtable R, Brangan E, Selman LE. Real-world ethics in palliative care: A systematic review of the ethical challenges reported by specialist palliative care practitioners in their clinical practice. Palliat Med. 2021 Feb;35(2):315-334. doi: 10.1177/0269216320974277.
3. Baumstarck K, Boyer L, Pauly V, Orleans V, Marin A, Fond G, Morin L, Auquier P, Salas S. Use of artificial nutrition near the end of life: Results from a French national population-based study of hospitalized cancer patients. Cancer Med. 2020 Jan;9(2):530-540. doi: 10.1002/cam4.2731.
4. Raijmakers NJH, van Zuylen L, Costantini M, Caraceni A, Clark J, Lundquist G, Voltz R, Ellershaw JE, van der Heide A; OPCARE9. Artificial nutrition and hydration in the last week of life in cancer patients. A systematic literature review of practices and effects. Ann Oncol. 2011 Jul;22(7):1478-1486. doi: 10.1093/annonc/mdq620.
5. Ganzini L. Artificial nutrition and hydration at the end of life: ethics and evidence. Palliat Support Care. 2006 Jun;4(2):135-43. doi: 10.1017/s1478951506060196.
6. Lee JH, Machtay M, Unger LD, Weinstein GS, Weber RS, Chalian AA, Rosenthal DI. Prophylactic gastrostomy tubes in patients undergoing intensive irradiation for cancer of the head and neck. Arch Otolaryngol Head Neck Surg. 1998 Aug;124(8):871-5. doi: 10.1001/archotol.124.8.871.
7. Huang ZB, Ahronheim JC. Nutrition and hydration in terminally ill patients: an update. Clin Geriatr Med. 2000 May;16(2):313-25. doi: 10.1016/s0749-0690(05)70058-6.
8. Good P, Richard R, Symmis W, Jenkins-Marsh S, Stephens J. Medically assisted hydration for adult palliative care patients. Cochrane Database Syst Rev. 2014 Apr 23;2014(4):CD006273. doi: 10.1002/14651858.CD006273.pub3.
9. Domeisen Benedetti F, Ostgathe C, Clark J, Costantini M, Daud ML, Grossenbacher-Gschwend B, Latten R, Lindqvist O, Peternelj A, Schuler S, Tal K, van der Heide A, Eychmüller S; OPCARE9. International palliative care experts' view on phenomena indicating the last hours and days of life. Support Care Cancer. 2013 Jun;21(6):1509-17. doi: 10.1007/s00520-012-1677-3.
10. Lau F, Cloutier-Fisher D, Kuziemy C, Black F, Downing M, Borycki E, Ho F. A systematic review of prognostic tools for estimating survival time in palliative care. J Palliat Care. 2007 Summer;23(2):93-112.
11. Geppert CM, Andrews MR, Druyan ME. Ethical issues in artificial nutrition and hydration: a review. JPEN J Parenter Enteral Nutr. 2010 Jan-Feb;34(1):79-88. doi: 10.1177/0148607109347209.
12. Varkey B. Principles of Clinical Ethics and Their Application to Practice. Med Princ Pract. 2021;30(1):17-28. doi: 10.1159/000509119.
13. Conselho da Europa. Guia sobre o processo de decisão relativo a tratamentos médicos em situações de fim de vida [Internet]. Estrasburgo: Comissão de Bioética; 2014 dez. Disponível em: <https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=090000168039e8c3>.
14. Simões FL, Sousa IE de, Carvalho AF de. Não iniciação ou suspensão de alimentação e hidratação artificiais – uma reflexão bioética baseada num caso clínico. cadernosdesaude [Internet]. 2021 [citado 2022 jun 24];13(2):43-7. Disponível em: <https://revistas.ucp.pt/index.php/cadernosdesaude/article/view/10219>.
15. Cardenas D. Ethical issues and dilemmas in artificial nutrition and hydration. Clin Nutr ESPEN. 2021 Feb;41:23-29. doi: 10.1016/j.clnesp.2020.12.010.